ONEMA-POP-022 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-022 — Triagem de Sinais de Alerta para
Pré-Eclâmpsia e Complicações Hipertensivas da Gestação

1. Identificação institucional

REVISÃO TÉCNICA DO RT

2. Objetivo e abrangência

Padronizar a abordagem de triagem de sinais de alerta para pré-eclâmpsia e complicações hipertensivas da gestação em atendimento domiciliar ou digital, conforme a pertinência. Não substitui avaliação médica ou atendimento de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e treinado. Gestantes após 20 semanas e puérperas com pressão elevada ou sintomas compatíveis; triagem não substitui avaliação obstétrica. Contraindicado manter cuidado eletivo quando presentes sinais de emergência ou quando o procedimento exceder a competência/estrutura disponível.

4. Materiais e fornecimento

Enfermeiro: esfigmomanômetro validado e manguito adequado, estetoscópio, oxímetro; paciente: cartão pré-natal, exames e medicações.

5. Avaliação e preparo

Idade gestacional/puerpério, histórico hipertensivo, cefaleia, alterações visuais, dor epigástrica, dispneia, edema súbito, convulsões e movimentos fetais.

6. Execução técnica numerada

1. Identificar gestante, idade gestacional e sintomas atuais; definir início e progressão.

2. Em visita presencial, medir pressão com técnica correta, repouso e manguito adequado; repetir para confirmar

achado quando clinicamente seguro.

3. Perguntar por cefaleia persistente, escotomas, dor no quadrante superior direito, dispneia, sangramento, convulsão

e redução de movimentos fetais.

4. Se pressão sistólica ≥160 ou diastólica ≥110 mmHg, ou sinais de gravidade, acionar urgência obstétrica/SAMU 192

sem aguardar exames.

5. Se pressão ≥140/90 mmHg sem sinais graves, orientar avaliação obstétrica no mesmo dia conforme rede e

condição clínica.

6. Não administrar anti-hipertensivos, sulfato de magnésio ou diuréticos sem prescrição e estrutura adequada.

7. Comunicar valores, horários, sintomas, idade gestacional e antecedentes ao serviço receptor.

8. Documentar destino, profissional contatado e confirmação de encaminhamento.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Convulsão, alteração de consciência, dispneia, dor torácica, cefaleia intensa ou PA grave: emergência imediata; não manter seguimento exclusivamente digital.

8. Cuidados posteriores e orientações

Não dirigir sozinha em situação de risco; levar cartão pré-natal e medicações.

9. Registros na Carteira Digital ONEMA

Identificação, data/hora e modalidade, consentimento, queixa e histórico, avaliação e sinais vitais pertinentes, achados objetivos, cada etapa executada e resposta, orientações, escalonamento/contatos, plano de retorno, identificação e assinatura do enfermeiro. Fotos somente com consentimento específico.

10. Referências rastreáveis

 NICE NG133 — Hypertension in pregnancy — https://www.nice.org.uk/guidance/ng133/chapter/recommendations

 WHO — Pre-eclampsia — https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pre-eclampsia

NOTA DE CONTROLE: referências identificadas e parcialmente conferidas; adequação à legislação brasileira, protocolos locais e

instruções de fabricante deve ser analisada pelo RT.